

안이비 14주차 써머리

01 구강과 총론

제 1장) 구강의 구조와 기능

1. 口腔(oral cavity)

- 소화관의 기시부.
- 크게 口腔前庭과 固有口腔으로 구분. 구순, 협부 점막, 상하치조능, 구후삼각, 경구개, 구강저, 구강부 혀로 세분됨
- 기능: 구강과 혀의 운동에 의해 咀嚼, 嚥下, 言語構成의 기능을 함

- 구성: 上壁, 下底, 側壁

① 上壁: 전반(경구개), 후반(연구개). 이들 口蓋는 前齒列로부터 뒤쪽으로 가면서 차츰 凹形의 만곡을 이루면서 아래로 내려가며, 입을 다물면 연구개, 설근부 및 후두개는 인두후벽에 밀착됨.

② 下底: 구강저. 좌우의 악설골근의 위(설하선), 밑(악하선) 위치. 뒤쪽(설근부), 앞쪽(치조돌기, 전치)로 구성. *알아두시는 게 좋아요

③ 側壁: 볼

1) 口脣(lips)

- 上, 下脣으로 구성. 두 입술의 사이(口裂), 이 두 입술의 접합부(口角), 상순의 중앙 상부(人中(philtrum)), 인중 하단의 입술 융기(상순결절), 하순 바로 밑의 窪部(頤脣溝), 鼻翼의 바깥쪽에서 측방과 상순의 위에 있는 얇은 구(鼻脣溝)가 있음.

- 구순 외면은 피부로, 구강쪽은 점막으로, 그 중간의 口裂에 面하고 있는 부위를 脣紅部라 하며

이행상피로서 毛와 汗腺은 없으나 그 측방에 皮脂腺 많이 분포.

- 주로 구륵근(orbicularis oris)으로 구성, 안면신경의 지배.
- 안면동맥 분지인 상하구순동맥

2) 口腔前庭(oral vestibule)

- 구순의 안쪽과 치조돌기 사이의 窪部. 상·하순소대, 상·하전정원개(협함물).

3) 頰(cheek)

- 구강 외벽. 협근(buccinator m.)으로 구성.
- 이하선 유두: 상 제2대구치의 상대부위에 이하선 개구부
- 협부 점막: 협부와 구순의 내측점막이며 동시에 구강전정의 외측벽을 구성

4) 天蓋(palate)

- 경구개와 연구개로 구분. 정중선의 융기(구개봉선), 상절단 후부에 있는 소용기(절단유두)가 있음.
- 경구개: 상악골의 구개융기와 그 후방에 접속된 구개골의 수평판으로 구성. 수평판의 후연 근처에는 크고 작은 두개의 구멍이 있는데, 前者를 대구개공, 後者를 소구개공이라 하며 각각 전·중·후 구개신경 및 대·소구개동맥이 나옴.

5) 口腔底(floor of the mouth)

- 하치조돌기와 양측 구개설골 사이. 구강저는 거의 혀 밑에 닿아있고 타액선을 피복.
- 치열궁을 따라서 혀 밑에는 설하후벽이 있어 설하선관 개구, 중앙에 악하선관 개구.
- 하악체 사이에 있는 악설골근(mylohyoid m.)사이 부위는 구강저 봉와직염 호발부위.

염천혈 위쪽(남성의 경우 Adam's apple 위쪽): 봉와직염 발생 시 촉진 가능

- 구강저의 기반이 되는 근육

- ① 악설골근: 구강저의 대부분을 차지. 구강저의 거상운동에 관여
- ② 이설골근: 설골의 거상운동에 관여
- ③ 이설근: 설근속으로 방산하는 주요 고유설근. 구강저 점막 아래 정중부를 지주함

6) 下顎(mandible)

- 하악지 및 하악체로 구성. 하악지의 상단에는 관절돌기와 근돌기가 있으며 근돌기에는 측두근이 건과 더불어 부착됨.

- 하악공(mandibular foramen) : 하악지의 중앙 내면에 하치신경과 혈관이 들어가는 구멍
- 이공(mental foramen) : 하악체의 전방이부. 신경과 혈관이 나오는 구멍
- 臼後三角(retromolar triangle) : 제3대구치의 후방에 2角으로 분지된 골릉이 있고, 대구치와의 사이에 형성되는 3角의 협소한 부분. **하악신경마비의 지표가 됨.** 사랑니가 나는 쪽 뒷부분(어금니 마지막)
- 하악의 근육
 - ① 교근: 협골궁에서 기시. 하악각의 전면에 걸쳐 하악지의 교근조면에 넓게 부착. 주로 입을 다무는 중요한 기능과 하악의 거상 및 전방운동에 관여
 - ② 측두근: 수축건으로 하악의 거상 및 후퇴운동을 담당 *측두근은 약간 애매~
 - ③ 익상근: 내. 외익상근. 이들 근의 좌우 교대 운동에 의하여 하악이 구쇄상운동을 함
 - ④ 악익복근: 설골을 고정 및 거상시키는 특수한 근육

2. 혀(tongue)

근육군. 점막으로 덮혀 있고 구강 속에 돌출하고 있으며, 입을 다물면 구강은 혀로 충만됨.

- 固定部와 可動部로 구분

1) 固定部 (후 1/3)

- 설골설근과 이설근으로 구성.

- 설하강 속에 위치, 설골과 하악에 고정.

- 구개설궁(palatoglossal arch): 혀를 고정시키는 중요한 역할.

2) 可動部 (전 2/3)

★ **혀의 가동부에서 구강부와 인두부를 나누는 경계가 되는 부위는?(15) 답: 분계구**

- 分界溝에 의하여 口腔部 및 咽頭部로 분류

① 구강부: 상면(설배), 하면 좌우(설연 및 설첨)로 구성. 설배는 담적색, 표면은 울퉁불퉁하고, 후부에는 유곽유두가 V자형으로 배열, 그 뒤의 분계구의 교점에 설맹공이 있고 그 앞의 설정중구에는 茸狀乳頭, 絲狀乳頭가 있으며, 혀 밑의 중앙에는 舌小帶가 있다.

② 인두부: 분계구 뒤의 설근부. 후두개곡에 연결, 설편도가 부착되어 있어凹凸이 심함.

- 점막 : 근육섬유가 붙어 있는 설배는 두껍고 아랫면은 얇다.

〈설의 특징적 구조〉 ★ 다음 중 지배신경이 다른 하나는? (14)

① 유곽유두(vallate papillae): 설 후면. **설인신경** 신경전달

② 용상유두(fungiform papillae): 설배면. 설신경

③ 사상유두(filiform papillae): 설배면. 설신경

④ 엽상유두(foliate papillae): 설측면. 설신경

⑤ 원추유두(conicae papillae): 설의 전면. 설신경

3) 혀의 筋肉, 血管

- 근육 : 8쌍 좌우 대칭.

① 혀의 돌출: 이설근(genioglossal m.)

② 후퇴: 하종설근(inferior longitudinal m.), 설골설근(hyoglossal m.)

③ 거상: 경돌설근(styloglossal m.), 구개설근(palatoglossal m.), 편도설근(tonsilloglossal m.), 인두설근(pharyngoglossal m.)

④ 연장: 횡설근(transverse lingual m.)

⑤ 단축: 상종설근(superior longitudinal m.)

- 혈관 : 외경동맥의 분지인 설동맥, 정맥은 동맥 수반 갑상설안면간 형성.

4) 혀의 淋巴, 神經

- 임파관: 점막 및 근육층에서 개별 淋巴管網을 만들어 서로 문합하여 악하림파절로 주입되고, 혀 끝에서는 이와 다른 임프관이 이하림파절에 주입.

- 신경

① 운동신경: **설하신경이 대부분을 지배, 이외 안면신경도 관여.**

② 지각신경:

- 혀 전 2/3: 3차신경의 3지인 **하악신경의 설신경.**

- 혀 후 1/3 및 설편도와 설후두개소대: 미주신경의 분지인 상후두신경.

3. 唾液腺(salivary gland)

★ 주타액선 3가지와 타액의 기능(02) / 타액선의 종류와 기능(03) -> 뒤의 생리 파트에서도 다룸!

- 주타액선인 耳下腺, 顎下腺, 舌下腺과 小唾液腺으로 분포.

- 주타액선: 쌍쌍으로 複合性 管胞狀腺(compound tubuloacinar gland)의 형태, 구강과 독립된 배설관으로 연결됨.

① 이하선: 장액선 세포.

② 악하선, 설하선: 장액 및 점액성 세포의 혼합성 세포.

- 소타액선: 구강내의 점막하에 위치. 짧은 흔적적인 관을 통하여 타액을 분비. 단순한 관상형 또는 관포형.

1) 이하선(parotid gland)

- 가장 큰 타액선. 주로 장액선 세포.

- 외이도 및 유양돌기 전하방의 이하선와에 위치. 육안적으로는 피라미드 모양.

- 주배설관: 이하선관(Stensen's duct). 길이는 성인에서 약 6cm로 상악 제2대구치의 대측 구강점막으로 개구.

- 외경동맥 지배.

2) 악하선(submandibular gland)

- 주로 장액선인 혼합선.

- 중량은 10~15g. 하악수평지 아래, 악하삼각에 위치.

- 주배설관: 악하선관(Wharton's duct). 길이가 약 5~6cm, 구강저 전면의 설소대 양측 하구에 개구.

cf) 악하삼각 : 악설골근과 하악체 및 전후 이복근으로 이루어지는 삼각부위.

3) 설하선(sublingual gland)

- 가장 작으며 주로 점액선.

- 구강저의 점막 깊이 이설근, 악설골근 위에 위치.

- 10~20개의 소구경관을 통하여 구강으로 타액을 배출. 악하선관으로 배출하는 것도 몇 개 있음.

4) 소타액선

- 구강은 입술, 구강협부, 구개 및 편도, 전. 후구개궁의 점막하에 위치한 소타액선들의 타액분비를 받음.

- 설근부의 근육과 설측연부의 근육에서도 선조적이 보임.

- 각각의 작은 타액선들은 작은 독립된 관을 통해서 구강내로 직접 타액을 분비.

4. 齒牙

- 구조

1) 치관(dental crown): 구강에서 관찰되어지는 법랑질(에나멜질)로 이루어진 부분

→ 제일 단단

2) 치근(dental root): 치조골 내에서 치관을 고정

3) 치은(gingiva)

- 치근은 주로 상아질로 구성되며 내측에 치수(dental pulp; 혈관, 신경, 온도, 통증, 압력을 감지하는 신경종말 유)가 있고 외측에 백악질(cementum)이 있음. 백악질외측으로 치주인대가 있어 치조골과 바로 접촉

제 2장)

생리

1. 口腔 生理

가) 음식물의 섭취 및 소화작용

① **저작기능**(mastication): 하악의 운동과 치아에 의한 食塊의 嚙切, 細碎, 口磨作用과 더불어 혀, 설, 구순 근육에 의해 음식물을 뒤섞는 혼합을 협동.

② **소화기능**(digestion):

- ㉠ 타액에 있는 전분소화효소에 의해 녹말이 당류(erythrodextrin과 maltose)로 분해됨.
- ㉡ 타액의 분비 : 구강 속의 감염 방지, 창양 치유, 구강점막이나舌苔의 변화 조절.

③ **연하기능**(swallowing): 구강을 구성하는 각 근육, 특히 혀, 연구개, 입술, 인두수축근, 후두근 및 식도의 협동작용.

★ 구강 생리에서 연하기능을 수의적 반사와 불수의적 반사로 구분하여 설명하시오. (15)

- 수의적 반사(구강준비기, 구강기), 불수의적 반사(인두기, 식도기)

① 수의적 반사 (ppt 내용 x, 선배 자료 참고했습니다.)

㉠ 구강으로 유입된 음식물을 식괴로 만든다.

- ㉡ 구강 뒤쪽으로 이동시켜 전구개궁에 닿게 해 뒤이어 불수의적인 반사가 일어나도록 한다.

② 불수의적 반사

- ㉠ 구강이 폐쇄.
- ㉡ 연구개의 거상에 의해 인두 및 비강이 폐쇄.
- ㉢ 인두의 거상과 설근의 후하방으로의 강하로 후두가 폐쇄.
- ㉣ 음식물이 하인두로 진입.

㉤ 식도 입구부의 개방과 더불어 식도벽의 연동운동으로 음식물이 하강.

나) 미각작용 ★ 구강의 생리 중 미각작용에 관하여 설명하시오. (00)

- 설유두에는 미각신경의 말초기관인 미뢰가 있으며 식물의 가용성 물질이 이것을 자극해서 생기는 감각을 미각이라 함.

① 기본이 되는 맛 교수님 曰 - 맛과 신경의 매칭은 중요해요~

- ㉠ 단맛: 혀의 전반부 -> 설신경
- ㉡ 쓴맛: 설근부(유곽유두) -> 설인신경
- ㉢ 짠맛: 혀끝과 설측부 -> 설신경
- ㉣ 신맛: 설측부 -> 설신경

② 부수적으로 맛을 이루는 요소

- ㉠ 식물의 온도, 경도.
- ㉡ 후소(嗅素) : 후비공에서 비강으로 들어가 후역을 흥분시켜 미각을 돕는 미각성 후각.



교수님 曰

후소와 관련된 미각성 비염: 간혹 자극적인 음식을 먹고 난 후 콧물이 흐르는 것.

심할 경우 어떠한 음식을 먹어도 콧물이 나온다. 마땅한 치료는 없고, 강한 자극 주는 음식 최대한 피하는 것 말고..

다) 구음작용

- 母音은 구강이 공명강이 되면서 音色을 띠

- 子音은 설, 연구개, 구순, 협부 등의 운동에 의해 구강 속에 각종의 협착부가 형성되어 발생

① 양 입술 사이의 음: p, b

② 상절치와 설첨 사이의 음: s, th

③ 구개와 설첨 사이의 음: t, d

④ 구개와 설근 사이의 음: k, g

2. 唾液腺 生理

타액은 하루에 약 1~1.5L 분비

- 대부분(약 99.5%)이 수분. 무기질로는 Na^+ , K^+ , Cl^- , HCO_3^- , Ca^{2+} 와 유기질로는 단백질, 요산, lysozyme, amylase, IgA, mucin, 혈액응고인자, 상피성장인자, 신경성장인자, renin 등으로 구성
- pH는 6.8~7.2이고 비중은 1.002 ~ 1.012이며, 또한 인산칼슘과 탄산칼슘은 타액 구성의 약 0.22%를 차지하는 중요한 鹽(salt)임. (염으로 인해 타석생김)

- 唾液의 기능

★ 타액의 기능 (04)

★ 타액의 기능 중 출혈이나 발한으로 수분의 과다손실 또는 섭취부족으로 구강건조를 유발하여 수분섭취를 하게 하는 기능은? (14)

- ① 소화기능: 구인두 및 식도로 음식물의 운반을 원활하게 하고 타액에 용해 가능한 물질들을 녹여서 미각을 도우며, 타액 속의 소화 효소는 녹말을 분해
- ② 보호기능
 - ① 기계적 보호: 음식 찌꺼기, 상피조직편, 세균 등을 희석시켜 제거. 점막의 피복과 윤활작용으로 구강과 구인두를 보호
 - ② 충치예방: 칼슘, 불소, 인산염 등이 치아를 성숙시키고 사기질의 용해를 감소. 또한 플라크에 축적된 산을 중화해 충치가 생기는 것을 방지
- ③ 항균: IgA, lysozyme, lacto-ferrin 등이 포함되어 세균에 대해 방어
- ④ 혈액응고와 상처치유 작용: 혈소판 활성화인과 함께 혈액응고인자 VII, VIII, IX, XII 와 유사한 작용을 하는 단백질이 구강 내 손상이나 수술 후의 혈액 응고에 도움을 줌

⑤ 항상성 유지: 출혈, 발한 등으로 수분의 과다손실 또는 섭취 부족으로 체내 수분이 손실되면 구강 건조 및 갈증을 유발하여 수분을 섭취하도록 함

<타액의 분비>

- 소타액선은 신경지배를 받지 않고, 주타액선은 교감 및 부교감신경의 이중지배를 받음.
- 부교감신경이 타액 생성에 일차적으로 작용. 교감신경은 타액 구성성분 조절에 주로 관여
 - ① 부교감신경 자극: 다량의 수분과 무기물이 더 분비되어 점도가 낮은 타액이 분비됨.
 - ② 교감신경 자극: 무기물과 유기물의 함량이 높아지고 점도가 높은 타액이 분비됨
초기에는 타액분비량을 증가시키나 자극이 지속되면 혈관수축으로 결국에는 분비량이 감소
 - ③ 신경지배 외에도 구강점막의 기계적, 화학적 자극 또는 위내용물에 의한 자극 등과 시각, 후각, 청각을 통한 조건반사에서도 분비되고, 사고 및 정서도 분비에 영향줌
- 타액 분비의 주간변화: 이른 아침에는 감소하나 오후에는 증가하며 수면 중에는 거의 분비가 없음.
- 연령별 : 출생 직후부터 3~5세까지는 증가하다가, 8~10세에는 감소되며 이후 30대까지는 서서히 분비가 증가하다가 연령의 증가에 따라서 감소됨 *애기들 침 흘리는 거: 자연스러운 현상
- 구강이나 인두의 갈증은 체액조절에 매우 중요. 체액이 감소하면 타액선이 탈수상태가 되므로 타액분비가 감소되고 이로써 갈증이 발생하여 수분 섭취를 하게 됨

참고> 口脣舌齒의 部位, 臟腑, 經絡 關係

1. 部位 및 構造

《靈樞. 腸胃論》《難經. 第四十二難》에서는 口の 크기는 二寸半이고 脣에서 齒까지 九分, 齒에서 會厭까지는 三寸半, 容量은 五合이고 舌의 무게는 十兩, 길이는 七寸半, 크기는 二寸半이라 하였다.

2. 臟腑와 關係

1) 心和 關係

心은 舌의 苗로 心이 舌을 主官하고 舌로 開竅하므로 心氣가 통하며, 心氣가 和하면 舌이 五味를 감별하고 또한 心은 小腸과 表裏關係를 이루고 있으므로 心和 小腸에 熱이 있으면 心火가 上炎해서 口舌에 瘡가 나타나며 舌尖이 붉어지고 舌腫과 舌衄이 발생된다 하였다.

2) 脾와 關係

口脣은 脾의 官으로 中營의 黃色은 脾에 통하고 口에 開竅되어 脾에 精이 藏해지는데 병이 있으면 舌本에 나타나며, 脾氣가 口로 통하여 脾氣가 和하면 五穀을 알 수 있다고 하였다.

《脈因證治》《證治彙補》에서는 脣病은 脾에서 주로 발생되는데 脾冷이면 脣에 紫色, 脾敗이면 黑色, 脾寒이면 青色, 脾虛이면 白色을 띠고 脾氣가 쇠약하면 黃色, 脾氣가 實하면 紅色을 보이며, 또한 脾熱은 虛熱로 滑苔를 보이고 舌強이 되며 脾氣가 鬱閉되면 白苔가 白雪狀을 띤다 하였다.

*입술의 색깔로 비기의 성쇠나 병변을 체크 가능

3) 胃와 關係

舌本の 上은 足陽明胃經, 舌本の 下는 手陽明大腸經이 散하므로 胃經과 大腸經에 病이 있으면 舌의 上下에 병변이 나타난다 하였다.

4) 肝과 關係 *간은 거의 언급 X

《靈樞. 經脈篇》에서는 厥陰은 肝脈이고 肝은 筋의 合이며 筋에는 陰氣가 聚合되어서 그 脈絡이 舌本에 있다 하였다.

《素問. 痿論》에서는 肝氣에 熱이 있으면 膽泄이 되어 口苦하며, 肝熱이 脾를 犯하면 脣과 齒齦에 腫痛이 나타난다 하였다.

5) 腎과 關係

《素問. 宣明五氣篇》에서는 腎은 骨을 主官하며 齒는 骨의 餘라 하였다.

《素問. 上古天真論》에서는 女子 七歲면 腎氣가 盛하여 치아가 자라게 되며 二十一歲에는 腎氣가 충만하여서 筋骨이 강성해지고 眞牙가 생겨 長極하고 五十에는 腎氣가 衰해 齒槁하고 六十四歲에는 拔齒가 된다 하였다. 주가되는건 수족양명경 / 얼굴로 수삼양경이 많이감.

3. 經絡과 關係 달기대비

- 十二經脈 中 구강을 순환하는 것

① 口齒 순환: 足陽明胃經, 手陽明大腸經

② 脣을 둘러싸면서 循行: 足陽明胃經, 足厥陰肝經, 督脈, 任脈

③ 舌을 순환: 足太陰脾經, 足少陰腎經, 足厥陰肝經

제 3장

병인과 병리

- 口脣舌齒病은 心, 肝, 脾胃, 腎, 大腸과 관련이 많다.

① 實證: 肝火, 心熱, 脾胃蘊熱, 胃火

② 虛證: 心脾兩虛, 腎精虧損, 腎虛熱

③ 臟氣의 偏勝으로 口中에서 五味가 나타남.

★ 무조건 나옴! (경악전서의) 중의외과에서 언급한 내용 -> 빈칸 채우기! (08,09,11,12,13,17,18)

口爲脾竅, 所以口腔病責脾, 證則虛實俱有; 舌病責心, 有實證·熱證而 無虛證·寒證; 齒病, 實者責陽明, 虛者責腎經. (干祖望 中醫外科)

구강에는에는 실증이 많고 허증은 덜하다(비위적열 / 심비적열) / 혀에는 책임이 심맥에 있음. (심열, 심비적열)

1. 病因

1) 外因 (心風, 傷寒)

- 主로 風, 寒, 濕, 熱邪 침범

① 風邪: 肝火가 있으면 쉽게 침입 - 舌卷, 舌強 不能言.

② 風寒邪: 대부분 氣血虛弱, 腎虛, 脾胃虛弱, 大腸虛弱한 때 침습 - 齒間에 유주 牙齒痛, 齒齦腫, 齒黃黑, 치아 탈락

③ 寒濕邪: 脾胃虛弱한 때 침범 - 口脣에 相搏되어 瘡腫, 糜爛, 腐爛 등

④ 風熱邪: 心脾積熱 또는 脾胃蘊熱한 때 침범 - 口, 舌, 脣에 瘡瘍과 疼痛 및 腫脹, 牙齒齦에 紅腫, 牙衄.

2) 內因 (七情)

- 心陰虛, 脾胃虛弱, 腎精虧損, 肝氣鬱結, 脾胃氣機 阻滯

3) 不內外因 (飲食勞役)

- 肥甘, 炙搏, 膏粱厚味, 寒冷한 음식을 過食, 또는 飢飽失常으로 발생

2. 病理

1) 外感邪毒(風熱, 風寒)

2) 脾胃蘊熱

3) 心脾積熱

4) 心火上炎

5) 肝鬱化火

6) 腎陰虧損

“風熱侵襲 居病因之首, 火熱濕鬱 爲病機之主, 臟腑病變 爲發病之本, 紅腫潰痛 該病症之標.”

1. 口腔의 視診

- 왼손으로 설압자를 잡고 설압자의 끝을 혀의 중앙 1/3과 후 1/3 부분의 경계 지점까지 넣고 엄지손가락을 지렛대로 하여 누르면서 살핍. 설압자를 너무 깊이 넣으면 구토 반사가, 너무 적게 넣으면 혀의 중앙이 융기되어 시야를 가리게 됨. 혀를 누르면서 전후구개궁, 구개편도와 인두후벽의 이상을 관찰하고 “아-”소리를 내게 하여 연구개 운동도 관찰
 - 구강점막 및 인두점막의 색깔, 종창 및 궤양의 유무, 구개편도의 상태,舌苔의 위축유무, 치아 및 치육의 상태, 연구개의 운동, 타액선 배설관구의 상태 등을 진단
- ① 구순: 투명한 편평상피, 血行이 많아 붉게 보임 - 빈혈, 脣裂(cleft lip) 및 口蓋裂(cleft palate) 등
 - ② 구강 점막: 미란, 궤양, 반점 및 색소침착, 위막 등의 유무 관찰 - 궤양성 구내염, 아프타성 구내염, 매독, 홍역, 아구창, Behcet氏 증후군 등. > 임상에서 제일 많이 봄
 - ③ 구강저: 舌筋群. 염증 발생시 쉽게 봉와직염으로 진행. 악성종양 빈발 - 구강저 봉와직염, 하마종, 피양낭종(dermoid ranula), 설소대단축증 등
 - ④ 경구개·연구개: 경구개에는 다소 요철, 연구개에서 마비나 구개열 등 관찰 - 타액선의 혼합종양, 구개암, 구개 천공, 연구개 마비, 혀 마비 등
 - ⑤ 치아: 치열의 상하교합 상태, 좌우 운동 상태, 치육 및 치아의 상태를 관찰 - 치육 출혈, 치근부 염증, 치아우식증 등

2. 舌의 視診

- 舌苔, 舌背 및 乳頭의 상태, 균열, 궤양, 경결의 유무를 관찰
 - 서양의학: 혀는 조직학적으로 박탈된 표피와 식물의 찌꺼기, 세균 등으로 되어 있고, 특히 구강이 청결하지 못할 경우에 더욱 잘 나타나며 음식물 및 약제의 색소에 의해서 영향 받음
- ① 구강 질환(작·연하가 안될 때), 만성 위장염, 위궤양, 위암: 더러운 회백색 두꺼운 혀
 - ② 열성 질환, 특히 장티푸스 : 암갈색의 혀
- 舌病의 종류
- ① 溝舌(fissured tongue): 선천 혹은 후천적으로 혀의 표면에 깊은 골이 생긴 것.
 - ② 正中菱形舌炎(median rhomboid glossitis): 발생학적으로 혀의 중앙부에 유두가 없이 매끈한 표면을 가지게 되거나 또는 융기가 되어 보이는 것. 염증 소견은 없음.
 - ③ 地圖狀舌(geographic tongue): 이동성 및 재발성 무늬가 발생하는 것.
 - ④ 黑舌(black tongue): 사상유두가 길게 증식되고 착색이 되는 것. 구강 위생 불결시.
한의학적으로 흑색은 안 좋은 것이지만, 흑설만 예외!
 - ⑤ 舌癌 : 설의 궤양 주위에 경결이 있는 경우, 특히 설측부의 후 1/3과 중 1/3 경계 부위.
*설암 관련: 잘 알아두는 것이 좋음 - 각론 파트의 흡연 부분과도 연관됨.
4, 5 잘기억하라 하심.(+백반증이 있는가도 잘 살펴보아야함. (암과 관련이 높기 때문)

3. 問診

- 구강내 동통, 종창감, 연하장애, 언어장애, 타액분비장애, 미각장애, 口臭의 유무. 또한 구강 질환과 관계가 깊은 소화기, 호흡기 및 혈액질환 유무도 관찰

(1) 구취

① 구강내 질환: 부패성 병변, 구강내의 염증·충치·농양·괴저 및 악성종양 등

② 구강 외의 질환: 만성 편도염, 만성 위장염, 폐괴저 등

(2) 설태

① 구강 불결, 위질환(만성 위장염, 위궤양, 위암): 회백색 두꺼운 껍

② 열성 질환, 특히 장티푸스: 암갈색의 껍

(3) 동통 및 섭식장애

① 구강내 통증 : 저작, 연하 운동시 심함. 각종 구내염, 특히 아프타성 구내염 때 심하고 궤양·위막성 구내염, 결핵, 매독, 악성 종양, 설근 농양 및 구강저 봉와직염 등에서도 동통이 심함

② 개구장애: 교근 자체 질환보다는 구강, 인두, 치아, 경부 관절 등에 원인

(4) 연하장애: 염증에 의한 동통 및 구강의 국소조건, 즉 구개궁 결손, 경·연구개 천공과 연구개 마비, 혀 운동장애, 종양 등에서 발생. 혀 운동장애만 있을 경우 인두협부 까지만 음식물이 통과하면 반사적으로 연하시킬 수가 있으며, 경·연구개의 결손 및 천공, 연구개 마비에서는 비강으로 음식물이 역류됨. (음식물이 식도로 넘어가야 하는데 비강 쪽으로 넘어감)

(5) 미각장애 ★미각의 퇴행을 일으키는 질환을 3가지 이상 서술하시오. (10)

- 미각장애: 미각과민, 미각감퇴, 미각결여로 구분 *미각과민 - 심리적 인자가 큼(환각느낌)

- 미각감퇴: 약물 내복, virus 감염, 두부외상에 의한 안면신경마비, 뇌매독, 과산화수소에 의한 미각신경마비, 심인성 및 삼차신경통

(6) 타액분비장애

- 구강내 분비물: 타액선의 타액(약알칼리)과 구강내 점막의 점액선에 의한 점액(약산성)이 혼합된 것. 정상인은 약알칼리 혹은 중성이나, 신생아나 포유아에서는 타액에 티오시아나트 칼륨(KSCN; potassium sulfocyanate)이 없어 산성을 띰.

- 鵝口瘡(thrush): 일반적으로 산성 타액에서 호산성 세균이 잘 번식하여 호발. 신생아 또는 성인에서 어떤 원인에 의해서 호산성 세균이 증식하면 아구창이 발생.

- 타액분비장애 분류

① 타액분비 감소: 열성 질환, 당뇨병, 콜레라, 惡液質 등과 같은 질환에서 심한 수분 손실로 점막 건조되어 발생. 이외 신경성 영향, 노인성 타액선 위축, 항암제 및 atropine 중독 등에서도 분비 감소

② 타액분비 증가(=流涎(saliva flow, salivation)): 위통, 유문협착, 구강점막의 자극(구내염, 의치 등), 히스테리, 고삭신경 이상, 연수마비, pilocarpine 중독, 수은중독 및 중추신경장애 등에서 발생. 생후 3~5개월 포유아에서는 생리적으로 발생 가능.

속이 굉장히 안 좋을 때 침이 계속 나오는 경험과 연관

(7) 음성 및 언어장애

- 구강에서의 음성은 주로 공명에 의한 것

- 공명장애 및 발음장애: 구강질환, 구개파열 및 천공, 연구개 마비 그리고 혀의 운동 장애가 있을 때 발생.

① 개방성 비음: 구개파열,천공,연구개 마비로 상인두와 구개수의 폐쇄 방해.

② 폐색성 비음: 구개궁의 종창, 침윤, 비인강 종양 등으로 상인두와의 교통이 끊겨 共鳴을 잃게 되어 발생.

③ 혼합성 비음: 비인강의 폐색이 완전치 않은 경우 발생.

- 언어장애

① 舌性 언어장애: 혀의 결손 및 운동장애시 “l, n, s, r, d, t, z, g, k” 등의 발음 장애

② 齒性 언어장애: 치아의 결손시 “d, t, n, s, z” 등의 발음 장애

③ 脣性 언어장애: 구순의 결손 및 종양시 “m, f, b, q, n” 등의 발음 장애

④ 口蓋性 언어장애: 구개의 질환으로 “g, k, j” 등의 발음 장애

(8) 설 및 연구개마비

- 중추성과 말초성으로 구분.

말초성으로 가장 흔한 것은 디프테리아 후 마비로 오는 연구개마비.

① 혀 마비: 혀를 입 밖으로 내밀었을 때 혀끝이 환측으로 향하고 마비쪽 근육들이 위축됨. 편측성 마비시 언어나 연하장애는 대개 없음.

② 연구개 마비: 개구한 채로 “아-”하고 발음시키면 구개수가 건강한 쪽으로 향하고 구개봉선은 환측으로 凸彎하며 개방성 비음이 있고 음식물이 비강으로 역류함

4. 觸診

- 양손 사용. 검사하는 손가락이 물리지 않게 하기 위하여 指甲을 사용하거나 혹은 다른 쪽의 제2·3지로 환자의 협부를 바깥쪽에서 구강 속으로 압박하여 상하치열 사이에 삽입하기도 함
- 순서: 치아연 -> 협과 치육사이 홈 -> 구강저 -> 점막이나 혀의 궤양, 종괴
- 안면 하반부의 촉진: 턱 밑 림프절, 하악지, 구륵근 및 협근의 운동상태, 치아를 악물었을 때의 교근의 강도, 악관절의 운동 등을 조사
- 치육 이상시 손가락이나 면봉 등으로 눌러서 누공이나 농즙의 유무 관찰
- 혀의 궤양주위에 경결이 있으면 설암의 가능성 고려

5. 味覺檢查(Gustometry)

(1) 미각검사 : 설점막의 장애뿐 아니라 지배 신경 장애와 부위 결정에 도움

- ① 방법: 식간 공복시 환자를 坐位로 하고 타액을 뱉은 다음에 味液(단맛: 5~10% 포도당, 신맛: 1~2% 주석산, 짠맛: 0.5~1% 생리식염수, 쓴맛: 0.02~0.2% 염산키니네액)을 면봉에 묻혀 혀의 각 부위에 바름. 이때 입맛을 못 보도록 입을 연 채로 단맛, 신맛, 짠맛, 쓴맛, 불명의 다섯 가지가 적힌 종이를 내놓아 가리키도록 함
- ② 미각 발현 시간 : 개인차가 있지만 약 5초 가량이면 나타남
- ③ 한 미액의 검사가 끝나면 물로 입을 헹군 다음 다른 미액의 검사
- ④ 쓴맛은 설인신경, 그 밖의 맛은 설신경을 통해서 중추에 전달되므로 장애 받는 신경 관찰가능.

(2) 전기미각검사(electrogustometry)

- ① 혀에 약간 직류전기를 통하면 양극에서는 신맛이 있는 금속미를 느낌.
- ② 무자극도자를 손에 잡게 하고 5mm직경의 스텐레스원판을 설정중선에서 약 2cm떨어진 설연에 대고 전류를 0.5~1.0초 통함.
- ③ 청년은 20 μ A 이하, 노년은 50 μ A이하에서 미각을 느낌.
- ④ 역치가 표준보다 높고, 좌우차가 50% 이상인 때에는 이상으로 판정.
- ⑤ 만일 300 μ A를 통해도 미각을 느끼지 못할 때에는 미각 완전탈실로 판정.

참고> 辨證 및 診斷 --> 내용이 많지만 수업을 가볍게 하신 편, 기출문제만 정리했습니다.

舌

* 舌苔質

- ① 厚薄 ② 潤燥 ③ 膩腐 ④ 剝落

⑤ 有根 및 無根苔: 正邪의 盛衰와 胃氣의 有無를 판단

★ 유근태와 무근태를 비교하여 설명하시오. (13)

- 舌苔가 堅實하게 부착되어 굵어도 벗겨지지 않는 것(=有根苔)
胃氣가 있음 - 主로 實證, 熱證

- 舌苔가 舌上에 얹혀 있는 것 같아서 굵으면 벗겨지는 것(=無根苔)
胃氣가 크게 損傷되었음 - 주로 虛證과 寒證.

齒齦 ★ 09,12 빈칸 기출 (00,04)

경악전서 치과 질환의 원인 3가지: 화, 충, 신허

《景岳全書》에서 牙齒病 三症이 있는데 첫째가 火(腸胃熱盛), 둘째가 蟲, 셋째가 腎虛하여 나타난다.

1. 治療

가. 內治法

- 1) 疏風清熱
- 2) 清心涼血
- 3) 祛痰除濕
- 4) 活血祛瘀
- 5) 祛腐排膿
- 6) 利膈通便
- 7) 補腎健脾
- 8) 補益氣血

나. 外治法

- 1) 吹藥 2) 含漱 3) 敷貼 4) 揩齒
- 5) 刺破(三稜鍼이나 刀尖으로 患處를 刺破 - 排膿과 瘀血 除去 - 泄熱止痛시키는 방법)

다. 鍼灸治療

- 주로 手足陽明經을 활용. 合谷, 陽谿, 手三里, 地倉, 四白, 大迎, 頰車, 下關, 內庭, 廉泉, 承漿, 金津玉液 등
- 금진옥액정도 사용.

2. 調護法

가. 口瘡

- 口舌瘡은 上焦熱에 의하므로 淸火해야 함
- 酒色, 勞倦過度로 인해 脈虛弱, 中氣不足 한 경우 寒涼藥을 쓸 수 없으므로 병의 근원을 살펴 心脾를 補하거나 腎水를 滋養

나. 口臭

- 생각한 바를 이루지 못하고 脾弱으로 運化하지 못할 때 발생
- 陽症은 淸胃火, 陰症은 補心脾

다. 口渴, 口乾

- 火가 위에서 旺盛하면 淸肺淸胃를, 水가 下位에서 虧損되면 補脾補腎함
- 陽虛하면 陰이 발생하지 않고 氣虛하면 精으로 化하지 못하므로 水火를 모두 고려하여 치료 물을 마시고 싶어하는게 구갈 / 물을 마시고 싶어하는 생각이 안드는게 구건

라. 生津潤口 導引法 탈기대비

- 방법: 입을 가볍게 벌리고 혀를 입천장에 닿게 하였다가 口脣을 살짝 다물면서 혀로 상하 치은과 입술사이를 회전하듯이 움직여 舌下에 津액이 차올라 口 안 가득 머금도록 한 후 서서히 삼킨다.
- 효과: 口舌乾燥 예방, 養陰, 益精, 強身함
- 유근태 : 설태가 견고하게 부착되어 끓어도 벗겨지지 않는 것 ->실열증
- 경악전서 : 아치병 삼증 : 첫째가 胃위열성 / 충 / 위허
- 마비가 아닌데 입이 뻐뚱어져서 오는 경우 ->턱관절 근육에 대한 교정
- 모든질환이 그렇지만 저녁에 심해지면 음허증 / 저녁에 약해지면 양허증(근데 피부질환같은 경우 그냥 저녁에 더 심한경우가 많다.)